

Результаты реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы в КазНИИОиР

Талаева Ш.Ж., Ли И.Н., Кайбуллаев Б.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Актуальность

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным онкологическим заболеванием женского населения. По данным ВОЗ, в мире каждый год регистрируется более 1 000 000 новых случаев РМЖ. В Республике Казахстан РМЖ представляет не менее актуальную проблему, что связано с высокой, постоянно возрастающей заболеваемостью и смертностью больных. Рак молочной железы занимает 2-е место в структуре всех злокачественных опухолей и 1-е – в структуре женской онкопатологии. Удельный вес женщин, больных РМЖ, в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) составляет 20,5%000, удельный вес смертности от РМЖ – 8,5%000. РМЖ характеризуется чрезвычайной вариабельностью клинического течения от агрессивного до относительно доброкачественного. Значительная часть больных РМЖ фактически имеет системный характер заболевания, потенциально излечимое только с помощью эффективной медикаментозной терапии, дополняющей локальное хирургическое и лучевое лечение. Осмысление этого взгляда привело к двум наиболее существенным изменениям в тактике лечения РМЖ. Первое коснулось вытеснения радикальной мастэктомии при относительно небольших опухолях в пользу внедрения органосохраняющего лечения. Второе заключается во все более широком применении адъювантной химио- и гормонотерапии сразу после хирургического вмешательства, а также более активного использования этих методов в предоперационном периоде для уменьшения размеров опухоли и создания возможности органосохраняющего лечения. Онкопластическая хирургия молочной железы – новое направление, сочетающее в себе базовые принципы пластической хирургии и онкохирургии с целью достижения оптимального результата как в онкологическом, так и в эстетическом аспектах.

Цель исследования

– изучение влияния реконструктивно-пластических операций на качество жизни больных раком молочной железы.

Материалы и методы

С мая 2010 года в отделении опухолей молочных желез КазНИИОиР проведено оперативное лечение с одномоментной пластикой 35 больным раком молочной железы T1-2N0-2M0 стадиями. Двое больных без предварительного лечения, две пациентки получили комплексное лечение (им была произведена отсроченная реконструктивно-пластическая операция ТДЛ и TRAM-лоскутом), 31 женщина – после проведения 4 курсов неоадъювантной полихимиотерапии (НАПХТ). Кожесберегающая мастэктомия в комбинации с имплантом была произведена 19 больным (54,3%), пластика торакодорзальным лоскутом в комбинации с имплантом была произведена 7 (20%) пациенткам, пластика TRAM-лоскутом – 4 (11,4%) больным,

КазОжР ғылыми-зерттеу институтында сүт безі рагіне жасалған реконструктивті - пластикалық операциялардың қорытындысы.

Талаева Ш.Ж., Ли И.Н., Кайбуллаев Б.А.

Мақалада берілген қорытындылар науқастарды сүт безі рагінен емдеуде қолданылған реконструктивті-пластикалық хирургия. Сапалы өмірдің құндылығы үшін Опросник MOS -36, осылардың критери көрсеткіштері сенімді болды негізгі топтан жоғары ($P<0,01$). Реконструкті операциялардың жасалуы маңызды дәрежеде науқастардың пайдасын арттырады, сүт безінен айрылған науқастар үшін ауыр эмоциялы соққы болмайды, қалыптасқанға дейін біршама жағдай тудырады.

Результаты реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы в КазНИИОиР

Талаева Ш.Ж., Ли И.Н., Кайбуллаев Б.А.

Целью нашего исследования стал поиск наиболее эффективных режимов неоадъювантной терапии местно-распространенных форм рака молочной железы. В сравнении со стандартной FAC-схемой химиотерапии, применение таксотера с 5-ФУ является приемлемой и альтернативной схемой у больных, имеющих противопоказание к антрациклиновым антибиотикам. Применение герцептина у больных с гиперэкспрессией Her-2 нец позволяет улучшить показатели объективного эффекта на 19,5% по сравнению с больными, не получавшими герцептин.

In this article were shown the results of treatment of patients with breast cancer with using oncoplastic surgery. We used the questions of MOS SF-36. The patients with breast cancer after reconstruction will be live as well as without disease.

мастэктомия в комбинации с имплантом Becker – 5 (14,3%) женщинам. Осложнения в виде краевых некрозов ткани молочной железы и частичного отторжения импланта наблюдались в 3 (8,6%) случаях (два из группы кожесберегающей мастэктомии, один при пластике торакодорзальным лоскутом). Последнее отмечалось у больных, которым в предоперационном периоде проводились курсы НАПХТ, и, по всей видимости, связано со снижением механизмов иммунной защиты. Контрольную группу составили 35 больных раком молочной железы T2-3N2M0 стадиями, которым после проведения 4 курсов НАПХТ была произведена радикальная мастэктомия.

Результаты лечения

Для оценки качества жизни использовался Опросник MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item Short Form

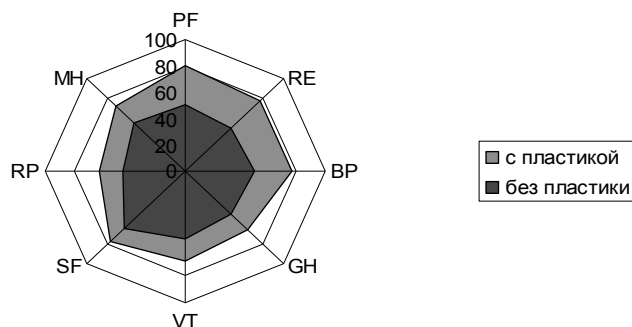


Рис. 1 - Влияние реконструктивных операций на качество жизни пациенток с раком молочной железы

Health Survey) по которым оценивался ряд критериев: General Health (GH), Physical Functioning (PF), Role-Physical (RP), Role-Emotional (RE), Social Functioning (SF), Bodily Pain (BP), Vitality (VT), Mental Health (MH). Все критерии оценивались по 10-балльной шкале, при этом в группе с пластикой молочной железы показатели PF, RE, BP, SF были $(79,6 \pm 0,8)$, $(79,5 \pm 0,9)$, $(79,4 \pm 0,9)$, $(79,6 \pm 0,8)$ баллов, показатель MH – $(73,96 \pm 1,3)$ баллов, показатели RP, VT, GH – $(59,3 \pm 0,9)$, $(59,5 \pm 0,8)$, $(59,4 \pm 0,9)$ баллов. В контрольной группе эти показатели составили $(39,5 \pm 0,6)$, $(39,4 \pm 0,7)$, $(39,3 \pm 0,77)$, $(39,5 \pm 0,6)$, $(34,1 \pm 0,8)$, $(29,4 \pm 0,7)$, $(29,5 \pm 0,7)$, $(29,4 \pm 0,7)$ баллов соответственно. Показатели критериев оказались достоверно выше в основной группе ($p < 0,01$) (рис. 1).

Выводы

Методика мастэктомии с сохранением кожи, покрывающей молочную железу, позволяет получить наилучший эстетический результат реконструктивной операции, не увеличивая вероятности местного рецидива. Психологические преимущества заключаются в снижении степени выраженности психологической травмы, когда отсутствует временной период жизни женщины без молочной железы и не формируются адаптационные механизмы, мешающие восприятию реконструированной железы при ее отсроченном восстановлении. Важным показателем успешной реконструкции может служить восприятие пациенткой реконструированной молочной железы как части собственного тела. Эстетические преимущества очевидны, так как реконструктивные вмешательства выполняются на неизмененных тканях, без рубцовых деформаций. С другой стороны, во время мастэктомии существует возможность сохранения большей площади кожи и субмаммарной складки, что оказывает значительное влияние на окончательные эстетические результаты. Практические преимущества включают в себя уменьшение количества оперативных вмешательств, снижение количества койко-дней и уменьшение себестоимости реконструкции в целом. Реконструктивно-пластические операции в свою очередь не влияют на течение опухолевого процесса больных раком молочной железы, существенно улучшая качество жизни.

Выполнение реконструктивных операций позволит в значительной степени увеличить долю больных, для которых потеря молочной железы не будет сопровождаться тяжелым эмоциональным стрессом, создавая условия для максимальной адаптации.